DIABETES — CUESTIONARIO 1

1. Un paciente de 20 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de Lantus (insulina glargina) en la noche y tres dosis de insulina cristalina, previas al desayuno, almuerzo y cena, presenta la siguiente tabla de glicemias promedio:

	HGT peprandial	HGT postprandial
Desayuno	80	120
Almuerzo	90	190
Cena	100	210

Además su hemoglobina glicosilada es de 8%. La conducta más adecuada es:

a.Aumentar la dosis de Lantus
b.Aumentar la insulina cristalina del desayuno y del almuerzo
c.Aumentar la insulina cristalina del almuerzo y cena
d.Aumentar la dosis de Lantus y de las 3 insulinas cristalinas
e.Agregar una dosis matinal de Lantus

2. Un paciente diabético de 50 años, en tratamiento con dieta, se realiza una prueba de lípidos, que muestra Colesterol LDL de 120 mg/dl, TG: 600 mg/dl, HDL: 30 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a.Manejar con dieta
b.Iniciar insulina
c.Iniciar una estatina
d.Iniciar un fibrato
e.Iniciar ácido nicotínico

3. Un paciente de 60 años se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 120 mg/dl. No ha presentado síntomas y su examen físico es normal. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

a.Test de tolerancia a la glucosa
b.Glicemia de ayuno
c.Índice de HOMA
d.Hemoglobina glicosilada
e.Insulinemia basal

4. Una paciente de 65 años, sin antecedentes mórbidos conocidos presenta un cuadro de palpitaciones, malestar y sudoración, luego de estar 5 horas sin comer. El cuadro se repite varias veces, siempre en relación al ayuno, por lo que decide hacerse un hemoglucotest, que demuestra una glicemia de 45 mg/dl durante uno de los episodios. ¿Qué examen es el más adecuado para determinar la etiología de la hipoglicemia?

a.Glicemia de ayuno
b.Test de tolerancia a la glucosa
c.Niveles plasmáticos de insulina
d.Niveles plasmáticos de glucagón
e.Niveles plasmáticos de péptido C

5. ¿Qué tratamiento está indicado ante la aparición de microalbuminuria persistente en un paciente con diabetes mellitus tipo 2?

a.Insulina
b.Dieta hipoproteica
c.Dieta hiperproteica
d.iECAs
e.Atorvastatina

6. Un paciente de 55 años, diabético tipo 2 en tratamiento con metformina 500 mg c/12 horas, presenta hemoglobina glicosilada de 8,5%, creatinina plasmática de 1,8 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 500 mg. La conducta más adecuada es:

a.Agregar glibenclamida
b.Aumentar la dosis de metformina
c.Iniciar insulina
d.Iniciar hemodiálisis
e.Hacer énfasis en el seguimiento de la dieta y correcto uso de los hipoglicemiantes orales y controlar con

7. Un paciente de 65 años, diabético tipo 2, de larga data, con tratamiento irregular con metformina y glibenclamida consulta por dolor intenso de la extremidad inferior izquierda, de tipo neurálgico, que recorre el dermatomo L4. Al examen físico se observa enflaquecido, con disminución de la sensibilidad distal y sin alteraciones motoras. La hemoglobina glicosilada resulta 9,9%. La conducta más adecuada es:

a.Reforzar el tratamiento con hipoglicemiantes orales y controlar en 3 meses
b.Suspender la glibenclamida y agregar insulina NPH nocturna
c.Indicar zapatos adecuados y revisión diaria de los pies y regularizar el tratamiento con hipoglicemiantes orales
d.Indicar un plan de ejercicios, reforzar la adhesión al tratamiento y controlar en 7 días
e.Hospitalizar, iniciar insulinoterapia y venlafaxina oral

8. Un paciente diabético tipo 2, acude a control ambulatorio. Actualmente está en tratamiento con metformina 850 mg cada 8 horas, aspirina 100 mg al día y enalapril 20 mg c/12 horas. En sus exámenes destaca creatinina 2,0 mg/dl, proteinuria 350 mg/dl, glicemia de ayuno: 140 mg/dl y HbA1c: 8,5%. La conducta más adecuada es:

a.Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
b.Aumentar la dosis de metformina
c.Agregar glibenclamida al tratamiento
d.Reemplazar la metformina común por metformina de liberación prolongada
e.Iniciar insulina

9. Un paciente de 60 años, hipertenso, sufrió un infarto de pared anterior hace 1 año, el que fue manejado con angioplastia. Acude a control, con un perfil lipídico, con los siguientes valores: colesterol total: 220 mg/dl, colesterol HDL: 40 mg/dl, colesterol LDL: 160 mg/dl, triglicéridos: 100 mg/dl. Refiere no tomar ningún medicamento hipolipemiante ni seguir ninguna dieta. La conducta más adecuada para el manejo de sus lípidos es:

a.Observar evolución
b.Indicar dieta baja en grasas trans, grasas saturadas y colesterol y controlar en 3 meses
c.Indicar dieta e iniciar una estatina
d.Indicar dieta e iniciar un fibrato
e.Indicar dieta e iniciar una estatina, asociada a un fibrato

El Indestructible...

10. Una paciente ha presentado 5 hipoglicemias, las que han requerido hospitalización en varias oportunidades. Niega antecedentes de importancia, pero los familiares sospechan que está autoinduciéndose los síntomas. En la última hospitalización se realiza estudio que revela insulina de 55 UI/L y péptico C elevado. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

a.Hipoglicemia facticia por insulina
b.Hipoglicemia facticia por metformina
c.Hipoglicemia facticia por glibenclamida
d.Hipoglicemia facticia por pioglitazona
e.Hipoglicemia de ayuno

11. Un niño de 8 años presenta un cuadro de astenia y baja de peso, de cerca de 2 semanas de evolución. Además, presenta poliuria y polidipsia importante. Se solicita una glicemia de ayuno, que resulta 220 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a.Repetir la glicemia en 7 días
b.Iniciar insulina NPH en dos dosis
c.Iniciar insulina es esquema intensificado, con una dosis de insulina ultralenta (glargina) más refuerzos con insulina cristalina
d.Solicitar test de tolerancia a la glucosa
e.Iniciar dieta, ejercicio y metformina

12. Un paciente de 56 años acude a control con el siguiente perfil lipídico: colesterol total: 348 mg/dl, colesterol HDL: 30 mg/dl, colesterol LDL: 190 mg/dl, triglicéridos: 640 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a.Iniciar dieta y ejercicio
b.Iniciar dieta y una estatina
c.Iniciar dieta y un fibrato
d.Iniciar dieta y una asociación entre una estatina y un fibrato
e.Hospitalizar e iniciar insulina cristalina

13. Un paciente de 45 años diabético, tipo 2, en tratamiento con metformina en dosis máxima, acude a control con los siguientes registros de glicemias promedio:

Predesayuno	90	Postdesayuno	140
Prealmuerzo	110	Postalmuerzo	190
Precena	135	Postcena	180

Además presenta una hemoglobina glicosilada de 7,5%. La conducta más adecuada es:

a.Agregar glibenclamida y mantener la metformina
b.Iniciar glibenclamida y suspender la metformina
c.Iniciar insulina NPH matinal
d.Iniciar insulina NPH nocturna
e.Iniciar insulina cristalina junto con las 3 comidas

14. Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con dieta, el que sigue de manera irregular, consulta por dolor en ambas extremidades inferiores, que es de tipo urente y que es especialmente intenso en la noche. Al examen presenta alodinia, sin focalidad neurológica, ni lesiones en la piel. La conducta más adecuada es:

a.Iniciar metformina y AINEs
b.Iniciar glibenclamida y clomipramina
c.Iniciar metformina y gabapentina
d.Iniciar insulina y pregabalina
e.Iniciar insulina y AINEs

15. Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 500 mg cada 8 horas, acude a control. Trae una hemoglobina glicosilada de 10,3% y una proteinuria de 24 horas en 500 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el control metabólico de este paciente?

a.Mantener la metformina y hacer hincapié en el cumplimiento de la dieta
b.Aumentar la dosis de metformina a 850 mg cada 8 horas y agregar enalapril
c.Agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas
d.Agregar sitagliptina
e.Iniciar insulina y valsartán

1. Un paciente de 72 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina, el que cumple de manera irregular, es traído al servicio de urgencia, por compromiso de conciencia. Los familiares refieren que desde hace 2 días está con tos con expectoración mucopurulenta y fiebre, pero que hoy empezó a decir palabras sin sentido y luego presentó tendencia a dormir. Al examen está en sopor profundo, sin signos focales, con signos de deshidratación, FC: 106x', PA: 100/60 mmHg, T°: 38,7°C y saturación arterial de oxígeno de 96%. Al examen pulmonar se auscultan crepitaciones en la base izquierda. Sus exámenes muestran hematocrito: 49%, blancos: 16.000 por mm3, plaquetas: 400.000 por mm3, glicemia 816 mg/dl, sodio: 143 mEq/L, potasio: 4,0 mEq/L, pH: 7,38 y bicarbonato: 23 mEq/L. La radiografía de tórax portátil muestra signos de condensación en el lóbulo inferior izquierdo. La conducta más adecuada es:

a.Administrar 1 litro de suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato por vía endovenosa
b.Administrar 1 litro de suero glucosado al 5% + 2g de NaCl + 1g de KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos endovenosos
c.Administrar 1 litro de suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos por vía endovenosa
d.Administrar 1 litro de suero glucosado al 5% + 2g de NaCl + 1g de KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato y antibióticos endovenosos
e.Administrar 1 litro de suero fisiológico, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos por vía endovenosa

2. Un paciente diabético tipo 1, presenta un cuadro de desorientación y luego convulsiones, que fue precedido por palpitaciones y temblor de las extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

a.Mielinolisis pontina
b.Accidente vascular encefálico
c.Encefalopatía de Wernicke
d.Cetoacidosis diabética
e.Hipoglicemia

3. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene diagnóstico de diabetes mellitus?

a.Paciente asintomático, con glicemia de ayuno de 290 mg/dl
b.Paciente con glicemia de ayuno de 198, que se repite a los dos días, resultando 138
c.Paciente con test de tolerancia a la glucosa, con glicemia basal de 110 mg/dl, que llega a los 180 mg/dl a las 2 horas postingesta de 75 gramos de glucosa
d.Paciente con hemoglobina glicosilada de 6%
e.Paciente con un hemoglucotest de 400 mg/dl

4. El hipotiroidismo suele presentar la siguiente alteración en el perfil lipídico

a.Colesterol LDL aumentado
b.Colesterol HDL aumentado
c.Colesterol HDL bajo
d.Triglicéridos aumentados
e.Colesterol LDL pequeño y denso

5. Un paciente de 18 años, diabético tipo 1, en tratamiento con insulina es esquema intensificado con dos dosis de insulina NPH y tres refuerzos con insulina cristalina, presenta los siguientes controles promedio con Hemoglucotest:

Predesayuno: 150	Postdesayuno: 210
Prealmuerzo: 90	Postalmuerzo: 120
Precena: 80	Postcena: 100

La conducta más adecuada es:

a.Aumentar la dosis de insulina NPH matinal
b.Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna
c.Aumentar la dosis de insulina cristalina predesayuno
d.Aumentar la dosis de insulina cristalina prealmuerzo
e.Aumentar la dosis de insulina cristalina precena

6. Un paciente indigente, en situación de calle, ingresa al servicio de urgencia por un cuadro de desorientación y dificultades para caminar. Al examen físico se constata estrabismo divergente, por parálisis del tercer nervio craneal izquierdo, ataxia de la marcha y desorientación temporoespacial, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a.Hipoglicemia
b.Hipofosfemia
c.Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
d.Encefalopatía de Wernicke
e.Encefalopatía de Korsakoff

7. Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 500 mg cada 8 horas, acude a control. Trae una hemoglobina glicosilada de 6,3% y una proteinuria de 24 horas en 200 mg/dl. Sin embargo, refiere que desde que inició la metformina, presenta diarrea y dolor abdominal ¿Cuál es la conducta más adecuada para el control metabólico de este paciente?

a.Mantener la metformina y hacer hincapié en el cumplimiento de la dieta
b.Aumentar la dosis de metformina a 850 mg cada 8 horas
c.Agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas
d.Reemplazar la metformina por rosiglitazona
e.Reemplazar la metformina por glibenclamida

8. Una paciente de 12 años, diabética tipo 1, en tratamiento con insulina, es traída al servicio de urgencia, por compromiso de conciencia. Los familiares refieren que desde hace 2 días está cursando con una infección urinaria, pero que hoy empezó a decir palabras sin sentido y luego presentó tendencia a dormir. Al examen está en sopor profundo, deshidratada, FC: 100x', PA: 90/60 mmHg, T°: 38,7°C y saturación arterial de oxígeno de 98%. Al examen pulmonar se aprecia polipnea. Sus exámenes muestran, glicemia 416 mg/dl, cetonas +++ en orina, sodio: 130 mEq/L, potasio: 4,6 mEq/L, pH: 7,18 y bicarbonato: 13 mEq/L. La conducta más adecuada es:	a.Administrar suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato por vía endovenosa b.Administrar suero glucosado al 5% + KCl endovenoso e iniciar insulina endovenosa c.Administrar suero fisiológico + KCl endovenoso e iniciar insulina endovenosa d.Administrar suero glucosalino + KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato endovenoso e.Administrar suero fisiológico + bicarbonato e iniciar insulina endovenosa
9. Un paciente diabético tipo 1, presenta un cuadro de desorientación y luego coma, que fue precedido por marcado malestar general, náuseas y dolor abdominal. El diagnóstico más probable es:	a.Síndrome hiperglicémico hiperosmolar b.Encefalopatía de Korsakov c.Encefalopatía de Wernicke d.Cetoacidosis diabética e.Hipoglicemia
10. Un paciente de 58 años, obeso, presenta un perfil lipídico con triglicéridos de 210 mg/dl, colesterol LDL: 180 mg/dl, colesterol HDL: 35 mg/dl y colesterol total: 257. Se inicia dieta y ejercicios y se controla tres meses después, sin lograr cambios. Su glicemia de ayunas es de 110 mg/dl y su TTGO resulta 150 mg/dl a las 2 horas postcarga de glucosa. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar una estatina y metformina b.Iniciar un fibrato y metformina c.Iniciar un fibrato y una estatina d.Iniciar metformina e.Mantener las indicaciones
11. Un paciente de 60 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg/8 horas y glibenclamida 5 mg en la mañana, acude a control, constatándose creatinina 1,0 mg/dl y hemoglobina glicosilada de 7,5%. La conducta más adecuada es:	a.Reemplazar la metformina por una glitazona b.Subir la dosis de glibenclamida c.Iniciar insulina d.Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses e.Solicitar un test de tolerancia a la glucosa oral
12. Un paciente de 58 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida y metformina en dosis máximas, acude a control. Presenta hemoglobina glicosilada de 6,8% y glicemias de ayuno entre 90 y 140 mg/dl. Su examen físico es normal y el resto de sus exámenes son normales. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar insulina NPH b.Solicitar test de tolerancia a la glucosa c.Suspender los hipoglicemiantes orales e iniciar insulina en esquema intensificado d.Mantener el tratamiento e.Agregar rosiglitazona al tratamiento
13. Un paciente de 45 años, con antecedente de lupus eritematoso sistémico, en tratamiento con prednisona, presenta glicemia de ayuno 180mg/dl y glicemias postprandiales sobre 210 mg/dl, siendo diagnosticada de diabetes mellitus. ¿Cuál es el tratamiento inicial en esta paciente?	a.Metformina b.Glibenclamida c.Pioglitazona d.Sitagliptina e.Insulina
14. Paciente de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo, presenta un cuadro de cetoacidosis diabética. No presenta antecedentes familiares de diabetes, sin antecedentes de importancia. Al examen físico, se encuentra IMC de 20,5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?	a.Diabetes mellitus 1 b.Diabetes mellitus 2 c.Diabetes mellitus LADA d.Diabetes mellitus MODY e.Cetoacidosis congénita
15. Paciente de 28 años, con diagnóstico de anorexia, desnutrida, que pesa 45 kilos y mide 1,75 metros, es hospitalizada para inicio de su alimentación por sonda nasogástrica, recibiendo una dosis de 2.000 calorías al día, en el primer día. Inicia con arritmia ventricular por torsión de puntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?	a.Déficit de vitamina B1 b.Déficit de vitamina B12 c.Síndrome de realimentación d.Hipercalcemia e.Hipoglicemia severa

DIABETES	CUESTIONARIO 3
1. Usted atiende a un paciente de 67 años, con antecedente de insuficiencia cardíaca CF II, como secuela de un infarto agudo al miocardio, que sufrió hace 5 meses. Actualmente es usuario de aspirina, atorvastatina y metformina en dosis máxima. Se realiza HbA1c, que resulta 7,5%. ¿Qué medida es más adecuada para su control metabólico?	a.Reemplazar la metformina por pioglitazona b.Agregar emplaglifozina c.Agregar glibenclamida d.Reemplazar la metformina por sitagliptina e.Mantener el tratamiento
2. Un paciente de 66 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg c/12 horas e insulina NPH 12 UI cada noche, se realiza exámenes de control, que muestran hemoglobina glicosilada de 7,8%, perfil lipídico adecuado. Además, se realiza controles frecuentes de glicemia capilar, que muestran que sus glicemias matinales tanto antes como después del desayuno están elevadas, mientras que las glicemias de la tarde y noche están normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada desde el punto de vista metabólico?	a.Aumentar la dosis de NPH nocturna b.Agregar una dosis de insulina NPH matinal c.Agregar insulina cristalina matinal d.Mantener el tratamiento sin cambios e.Cambiar el horario de la insulina NPH a la mañana
3. Un paciente de 34 años es ingresado al servicio de urgencia, debido a un cuadro de cetoacidosis diabética, el que es manejado adecuadamente. No tenía diagnóstico previo de diabetes y como antecedentes solo tomaba levotiroxina, con buen control y polivitamínicos. Al quinto día de hospitalización, su examen físico es normal y se mantiene con glicemias normales, con bajas dosis de insulina cristalina c/6 horas, por lo que se encuentra en condiciones de ser dado de alta. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo glicémico al alta?	a.Indicar insulina glargina más 3 dosis de insulina cristalina b.Indicar metformina oral en dosis máxima c.Indicar insulina cristalina cada 6 horas d.Indicar metformina y sitagliptina en dosis altas e.Indicar insulina NPH nocturna
4. Un paciente de 10 años presenta un cuadro de dolor abdominal y vómitos, asociado a deterioro del estado general y desorientación. Su madre refiere que desde hace 4 días que ha estado decaído, con náuseas y que el día de hoy comenzó con vómitos, desorientación y tendencia al sopor. Al examen físico, está desorientado en el tiempo y espacio, pero no tiene focalidad neurológica; se observa taquicárdico a 110x', con FR: 23x', PA: 90/60 mmHg y Tº: 37,0ºC. Su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en 2 tonos, sin soplos y murmullo pulmonar presente sin otros ruidos. Su examen abdominal muestra abdomen blando, sin signos peritoneales. Se instala una vía venosa, para reposición de fluidos y administración de fármacos. ¿Qué examen es más adecuado para iniciar su estudio?	a.Endoscopía digestiva alta b.TAC de abdomen y pelvis c.Radiografía de tórax y abdomen, en posición de pie d.Glicemia e.Laparotomía exploradora
5. Un paciente de 56 años, diabético tipo 2, mal controlado, se realiza un fondo de ojo, que muestra exudados céreos bilaterales y periféricos, con algunas microhemorragias, exudados algodonosos y vasos de neoformación. El paciente refiere que ve perfectamente y que está dispuesto a mejorar su adherencia a tratamiento, admitiendo que olvida tomar sus medicamentos (metformina 850 mg c/8 horas y glibenclamida 5 mg c/12 horas) la gran mayoría de los días. Su hemoglobina glicosilada es 8,5%. Además de insistir en la importancia de seguir las indicaciones médicas, ¿cuál es la conducta más adecuada?	a.Reemplazar los hipoglicemiantes por insulina glargina más 3 refuerzos de insulina cristalina b.Solicitar un nuevo fondo de ojo en 3 meses c.Derivar a oftalmología para fotocoagulación láser e inicio de fármacos antiangiogénicos d.Reemplazar los hipoglicemiantes orales por insulina NPH e.Realizar evaluación del rojo pupilar
6. Un paciente de 55 años, diabético tipo 2, diagnosticado hace 6 meses, está en tratamiento con metformina 850 mg XR c/12 horas. Su HbA1c resulta 6,5%, sin embargo, refiere que, desde el diagnóstico, presenta diarrea y náuseas que le son muy molestas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?	a.Solicitar colonoscopía, endoscopía digestiva alta, anticuerpos anti-TGR, ASCA y ANCA. b.Indicar dieta baja en fibra c.Disminuir la dosis de metformina d.Reemplazar la metformina por otro hipoglicemiante oral e.Reemplazar la metformina por insulina
7. Un paciente de 55 años, obeso y diabético tipo 2, diagnosticado hace un año, acude a su segundo control. Está en tratamiento con metformina XR 850 mg cada 12 horas y dieta. Su IMC se ha mantenido en 37 desde que fue diagnosticado. Su hemoglobina glicosilada resulta 9,5%, su glicemia de ayuno: 105 mg/dl, su fondo de ojo es normal, al igual que sus pruebas de función renal. Niega cualquier síntoma y su examen físico es normal. Además de reforzar las medidas no farmacológicas, la conducta más adecuada es:	a.Agregar sitagliptina al tratamiento b.Aumentar la metformina XR a 850 mg cada 8 horas c.Explicar que no es necesario hacer cambios en su tratamiento farmacológico d.Agregar insulina NPH nocturna al tratamiento e.Agregar glibenclamida al tratamiento
8. Un paciente de 66 años, con antecedente de diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, pie diabético y cirugía de revascularización femoropoplíteo se realiza exámenes de control, que muestran	a.Agregar gemfibrozilo 600 mg/día b.Reemplazar el enalapril por atenolol

colesterol HDL: 30 mg/dl, colesterol LDL:100 mg/dl, triglicéridos: 490 mg/dl y colesterol total: 228 mg/dl, glicemia de ayuno: 120 mg/dl, hemoglobina glicosilada: 6,9%, relación albuminuria / creatininuria: 0,02, creatinina: 1,1 mg/dl, BUN: 18 mg/dl. Actualmente utiliza metformina en dosis máxima, aspirina, enalapril 10 mg c/12 horas y amlodipino 10 mg/dl. Su presión arterial promedio es 128/78 mg/dl. ¿Qué conducta es la más adecuada?	c.Reemplazar el amlodipino por hidroclorotiazida d.Agregar un segundo hipoglicemiante oral e.Agregar atorvastatina 20 mg/día
9. Un paciente de 67 años, diabético tipo 2, con mal control, consulta por parestesias y dolor urente en las extremidades inferiores. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad termalgésica distal y presenta alodina importante. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo del dolor?	a.Celecoxib b.Prednisona c.Venlafaxina d.Tramadol e.Paracetamol
10. Un paciente de 60 años ha presentado varios cuadros de palpitaciones y sudoración, que han sido catalogados como arritmias o crisis de pánico. Se ha realizado holter de arritmias, TSH y exámenes generales, que han resultado normales. En el último episodio, se tomó la glicemia capilar, dado que su esposa es diabética y, para su sorpresa, marcó 45 mg/dl, por lo que tomó agua con azúcar, desapareciendo los síntomas a los pocos minutos. Su examen físico es normal. Además de una anamnesis detallada, ¿qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?	a.Glicemia de ayuno de 24 horas b.Anticuerpos anti-insulina, anti-GAD, anti-tirosinfosfoquinasa 2 y anti-transportador de Zinc 8 c.Test de tolerancia a la glucosa oral d.Hemoglobina glicosilada e.Niveles plasmáticos de insulina y péptido C
11. Tiene una hipoglicemia, cumpliendo con la triada de Whipple (1. Síntomas simpáticos o neuroglucopénicos, 2. Simultáneos a glicemias bajas objetivadas, 3. Que responden a consumo de azúcar). La insulinemia y el péptido C ayudan a identificar la casusa. Además, se deben repetir los desencadenantes (ayuno o comida, según sea el caso) y realizar glicemias seriadas. La hemoglobina glicosilada se usa en la diabetes y no en las hipoglicemias. Los marcadores de autoinmunidad de la diabetes se usan ante la sospecha de diabetes LADA y tipo 1. La respuesta correcta es: Niveles plasmáticos de insulina y péptido C	a.Intolerancia a la glucosa oral b.Diabetes gestacional c.Embarazo normal d.Diabetes pregestacional e.Glicemia de ayuno alterada
12. Un paciente de 18 años, diabético tipo 1, en tratamiento, presenta compromiso de conciencia, de 20 minutos de evolución. Previo a esto presentó un cuadro de malestar general de 2 días de evolución, en contexto de una infección respiratoria. Al examen físico está en sopor profundo, con FR: 25x', saturación: 99%, FC: 120x' y PA: 100/60 mmHg. Su hemoglucotest resulta 450 mg/dl y se solicitan exámenes de laboratorio, que están pendientes. La primera medida es:	a.Administrar bicarbonato endovenoso b.Administrar suero fisiológico endovenoso c.Administrar suero glucosado endovenoso d.Administrar oxígeno por mascarilla e.Administrar insulina endovenosa
13. Un paciente de 35 años, con antecedente de hipotiroidismo es diagnosticado de diabetes mellitus, mediante dos glicemias de ayuno, de 205 y 224 mg/dl, respectivamente. Inicia tratamiento con dieta y metformina 500 mg cada 8 horas, con empeoramiento de sus glicemias en los 3 meses siguientes. Sus niveles de HbA1c resultan 9,9% y su péptido C está muy disminuido. La conducta más adecuada es:	a.Reemplazar la metformina por sitagliptina b.Aumentar la dosis de metformina a 1 g cada 8 horas c.Reemplazar el tratamiento por insulinoterapia en esquema intensificado d.Agregar glibenclamida 10 mg c/12 horas e.Agregar insulina NPH nocturna
14. Un paciente de 66 años es hospitalizado por una pielonefritis aguda. En su hemoglucotest de ingreso, se constata una glicemia capilar de 356 mg/dl. Además, se solicita una glicemia en sangre venosa, con un resultado de 230 mg/dl y hemoglobina glicosilada de 8,5%. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de la hiperglicemia en este momento (durante su hospitalización)?	a.Debe manejarse con insulina cristalina, en cuatro dosis diarias b.Debe manejarse con metformina más glibenclamida, por vía oral c.Debe manejarse con metformina sola d.Debe manejarse con insulina NPH, en dos dosis diarias e.Dado que solo tiene una glicemia venosa elevada y no tenía síntomas de diabetes, lo más adecuado es indicar solo dieta